Ostéopathies métaboliques

Maladies inflammatoires, dégénératives et métaboliques de l'os — VI

À RETENIR

- Aspect commun aux maladies métaboliques avec ↑ du renouvellement osseux : la « trop belle image » = **Super Scan**.
- Hyperfixation diffuse des os longs, du squelette axial, péri-articulaire, de la voûte crânienne et du maxillaire inférieur, JCC en chapelet, **sternum en cravate**.
- **Images rénales atténuées voire absentes**, fixation des parties molles ↓.
- Aspect régulier et **symétrique** → diagnostic différentiel avec les métastases ostéomédullaires diffuses.
- HPT : excès de PTH ; fractures à distance des articulations ; **tumeurs brunes** rares.
- Ostéomalacie : carence en vitamine D ; **pseudo-fractures de Looser-Milkman**.

1. Généralités : le « Super Scan »

Aspect commun à la majorité des maladies métaboliques qui s'accompagnent d'une ↑ du renouvellement osseux : la trop belle image scintigraphique, « **Super Scan** ».

Sémiologie scintigraphique

- Hyperfixation diffuse des os longs sur toute leur longueur.
- Hyperfixation diffuse du squelette axial.
- Hyperfixation péri-articulaire.
- Hyperfixation de la voûte crânienne + maxillaire inférieur.
- Hyperfixation en chapelet des jonctions chondro-costales (JCC).
- Sternum « en cravate ».

Avec :

- images rénales atténuées, voire quasi absentes ;
- aspect de fixation ↓ des parties molles ;
- aspect régulier et répartition **symétrique** (ce qui permet de faire le diagnostic différentiel avec les lésions métastatiques ostéomédullaires diffuses).

2. Hyperparathyroïdie

Excès de production et de sécrétion de PTH, avec augmentation du renouvellement osseux :

- hyperfixation : voûte crânienne, massif facial, sternum, corticales des os longs ;
- foyers de fixation à distance des articulations : fractures ;
- **tumeurs brunes** (rares) :
  1. hyperfixations multiples ;
  2. lésions ostéolytiques parfois expansives, cernées d'ostéosclérose.

3. Ostéomalacie

- Carence en vitamine D avec raréfaction de la matrice protéique + ostéoporose **[à vérifier]** *à vérifier : l'ostéomalacie correspond classiquement à un défaut de minéralisation de la matrice ostéoïde*.
- ⇒ Hyperfixation homogène + foyers d'hyperfixation : **pseudo-fractures de Looser-Milkman**.
- ⇒ Diagnostic différentiel avec les métastases :
  - fractures des côtes : non alignées sur les côtes superposées, moins nettes qu'en cas de fracture post-traumatique ;

- foyers costaux multiples + absence de foyers rachidiens ⇒ étiologie maligne très improbable.

4. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

- Ostéopathie métabolique : SBS (Super Bone Scan) avec ↑ fixation du crâne, de la face, du maxillaire inférieur, sternum en cravate, JCC, renforcement péri-articulaire, ↑ fixation des os longs jusqu'aux extrémités.
- + pseudo-fractures de Looser-Milkman (ostéomalacie) ; fractures ou tumeurs brunes ⊕ HPT ; calcifications… (suite masquée sur le scan).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que le « Super Scan » métabolique ?	Une trop belle image : hyperfixation diffuse et symétrique du squelette avec reins atténués voire absents.
2. Quels signes orientent vers une cause métabolique plutôt que métastatique ?	Aspect régulier et répartition symétrique.
3. Citez deux aspects typiques du Super Scan métabolique.	Sternum en cravate ; JCC en chapelet (aussi voûte crânienne et maxillaire inférieur).
4. Aspect scintigraphique des tumeurs brunes ?	Hyperfixations multiples ; lésions ostéolytiques parfois expansives cernées d'ostéosclérose.
5. Lésion typique de l'ostéomalacie ?	Les pseudo-fractures de Looser-Milkman.
6. Quel argument rend une étiologie maligne très improbable devant des foyers costaux ?	Foyers costaux multiples sans foyers rachidiens.